ONEMA-POP-036 — Versão institucional 1.0

Status: Aprovado pelo RT · Vigência: 09/11/2026 · Responsável técnico: Enf. Marcos Roberto Alves, COREN-SP 983558

ONEMA-POP-036 — Manejo do Estertor Respiratório no Processo de
Morte e Apoio à Família

1. Identificação institucional

983558 | Data: 09/11/2026.

2. Objetivo e abrangência

Padronizar manejo do estertor respiratório no processo de morte e apoio à família na atuação da rede ONEMA ONE, com avaliação, execução segura, continuidade e escalonamento. Aplicável ao atendimento domiciliar e, quando pertinente, digital; não substitui decisões médicas nem suporte de emergência.

3. Competência, indicações e contraindicações

Execução e julgamento clínico por enfermeiro habilitado, conforme competências e treinamento. Indicações: Pessoa em fase final de vida com secreção respiratória ruidosa; foco em conforto e apoio à família. Contraindicações operacionais: ausência de consentimento ou de condições seguras, urgência incompatível com atendimento eletivo, ou ação fora da competência/prescrição.

4. Materiais, equipamentos e fornecimento

Enfermeiro: EPI, materiais de higiene oral, suporte para posicionamento; paciente: medicações prescritas e plano paliativo. Em visitas presenciais, o profissional dispõe de aparelho de pressão validado, estetoscópio, termômetro e oxímetro; utilizar conforme avaliação. Insumos específicos são providenciados pelo paciente/responsável, salvo acordo contratual.

5. Avaliação clínica e preparo

Nível de consciência, sofrimento aparente, quantidade de secreção, posição, sinais de aspiração e percepção familiar. Confirmar identidade, consentimento, privacidade, ambiente e plano prévio; estabelecer linha de base e reconhecer urgências antes de iniciar.

6. Execução técnica numerada

1. Confirmar fase clínica e plano de fim de vida com equipe responsável.

2. Explicar à família que ruído respiratório pode decorrer do acúmulo de secreções e não indica necessariamente

sofrimento.

3. Avaliar desconforto do paciente, expressão facial, agitação e esforço respiratório.

4. Ajustar decúbito suavemente e realizar higiene oral; evitar manobras desconfortáveis.

5. Não instituir aspiração profunda rotineira ou hidratação excessiva para tentar eliminar ruído.

6. Verificar se há prescrição de antissecretório e administrar somente conforme indicação, avaliando efeitos adversos.

7. Reavaliar ruído e, principalmente, conforto; comunicar persistência de sofrimento à equipe paliativa.

8. Registrar observações, preferências familiares, medidas realizadas e resposta.

7. Interrupção, intercorrências e encaminhamento

Se houver sinais de obstrução aguda, aspiração importante ou desconforto grave fora do plano esperado, acionar equipe

assistencial imediatamente. Em emergência, acionar SAMU 192 e registrar horário e destinatário; não retardar

atendimento por registro digital.

8. Cuidados posteriores e orientações

Oferecer apoio e explicações claras; evitar procedimentos invasivos sem benefício provável. Confirmar compreensão por

retorno verbal e definir quem será contatado em caso de piora.

9. Registros obrigatórios na Carteira Digital ONEMA

Identificação, data/hora e modalidade, consentimento, queixa, histórico e avaliação, sinais vitais pertinentes, diagnósticos

e plano de Enfermagem, passos executados e não executados com justificativa, resposta clínica, intercorrências,

orientações, contatos e encaminhamentos, profissional responsável e assinatura/trilha de auditoria.

10. Referências técnicas específicas e rastreáveis

 NICE NG31 — Care of dying adults in the last days of life —

https://www.nice.org.uk/guidance/ng31/chapter/Recommendations

 OMS — Palliative care, fact sheet — https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care

 COFEN, Resolução nº 736/2024 — Processo de Enfermagem —

https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-736-de-17-de-janeiro-de-2024/